HELP_Organi_P17 — Groupe D — Lots 237 à 241 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 17 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

D-025 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.3 › point 11.B › tableau « Reprise du P2Y12 » ; point 9.a ; fenêtre « alternatives (grossesse, enfant) »

Contexte : Le cours écrit : date de reprise du P2Y12 après chirurgie non trouvée ; aucun test de fonction plaquettaire retenu ; gestion périopératoire de la DAPT chez la femme enceinte et chez l'enfant non trouvée.

Question : Quel délai de reprise du clopidogrel, du prasugrel et du ticagrélor après chirurgie (selon le risque hémorragique) recommandent l'ESC 2022 (chirurgie non cardiaque) et l'ESC 2023 (syndromes coronariens aigus) ? Les tests de fonction plaquettaire ont-ils une place (classe) pour décider du moment de l'opération ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-026 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › point 11.B › fenêtre « ③ Érythropoïétine, acide tranexamique, transfusion » ; A › Bloc 1 (smarter medicine n° 2)

Contexte : Le cours et l'audit citent Smarter Medicine 2018 (médecine interne hospitalière) : seuil transfusionnel « > 70 g/L », à confirmer sur le PDF.

Question : Quel est le texte exact de la recommandation Smarter Medicine 2018 (médecine interne hospitalière) sur la transfusion (seuil d'hémoglobine, exceptions coronariennes) ? Une version plus récente existe-t-elle ? Quel seuil retiennent les recommandations européennes 2023 (ESAIC, saignement périopératoire) et les directives suisses de gestion du sang du patient (PBM) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-027 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › point 8 (STOP-Bang), point 9 (polysomnographie, IAH) et point 11.B–C (CPAP, surveillance postopératoire du SAOS)

Contexte : Le cours écrit : seuils d'âge (> 50 ans) et de tour de cou (> 40 cm) du STOP-Bang non sourcés ; recommandation ESAIC sur la CPAP périopératoire non trouvée ; surveillance postopératoire spécifique (CPAP, monitorage) non trouvée ; un panel international 2026 recommande l'assistance non invasive.

Question : L'ESAIC ou une autre source européenne (ERS, SSAPM, Ligue pulmonaire suisse) recommande-t-elle la CPAP en périopératoire chez le patient avec SAOS connu ou suspecté, avec quelle force de recommandation ? Quels seuils du STOP-Bang (âge, tour de cou, IMC) et quel score orientent vers un SAOS modéré à sévère ? Quelle surveillance postopératoire (SpO_2 continue, durée) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-031 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 11.B › fenêtre « antibioprophylaxie »

Contexte : Le cours donne le moment (0–60 min avant l'incision), la réadministration et la durée ≤ 24 h ; molécule et dose non trouvées.

Question : Quelle molécule et quelle dose d'antibioprophylaxie chirurgicale (céfazoline, adaptation au poids > 120 kg, alternative si allergie aux bêta-lactamines) recommande Swissnoso (version la plus récente) ? Différences avec l'ECDC/ESCMID ? Citer la recommandation suisse en vigueur (titre, année, URL) ; comparer la version la plus récente à celle du cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-033 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc DX.4 › point 11.B › tableau « Médicaments cardiovasculaires périopératoires » (colonne doses/délais) ; fenêtre DFGe < 30

Contexte : Le cours résume l'ESC 2022 [S7] : poursuivre antihypertenseurs, statines, traitement de l'insuffisance cardiaque ; amiodarone préventive ; colonne posologie « donnée non trouvée » ; interprétation du BNP et de la troponine en insuffisance rénale non trouvée.

Question : Selon l'ESC 2022 (texte original), quelles conduites précises : arrêt des IEC/ARA la veille ou non, bêtabloquants (ne pas initier), diurétiques, iSGLT2 (arrêt 3 jours avant), statines, amiodarone préventive (dose et schéma) ? Comment interpréter BNP et hs-cTn si DFGe < 30 mL/min/1,73 m² ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-034 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › fenêtres « hypertension artérielle » et « pression artérielle de repos »

Contexte : Le cours écrit : seuil de pression artérielle justifiant un report de l'intervention non trouvé.

Question : À partir de quelle pression artérielle (p. ex. ≥ 180/110 mmHg) l'ESC 2022 ou l'ESH 2023 recommandent-elles de reporter une chirurgie élective ? Quelle classe et quel niveau de preuve ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-037 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › point 9 › tableaux DFGe, créatinine, ClCr ; fenêtre « stades KDIGO de l'IRA » ; fenêtre « hydratation intraveineuse préventive » ; points 9.c (grossesse, contraste) et 11.D

Contexte : Le cours cite l'ESUR [S24][S25] et KDIGO : valeurs de référence suisses du DFGe et de la créatinine, délais de contrôle et prise en charge par stade KDIGO, seuils de récupération et conduite en grossesse non trouvés ; correspondance des niveaux de preuve ESUR à confirmer.

Question : Que recommande la version la plus récente de l'ESUR (Contrast Media Safety Committee, version 10.0 ou ultérieure) pour la prévention de la PC-AKI : seuils de DFGe, protocole et volume d'hydratation (mL/kg/h), metformine, délais de contrôle de la créatinine, grossesse ? Quels délais de contrôle et quelle prise en charge par stade KDIGO 2012 (ou mise à jour KDIGO AKI 2025/2026) ? Quelle position de la Société suisse de néphrologie ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-038 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.8 › point 9 (étalon-or carence martiale, B12/folates) ; point 11.B › fenêtres « ① Fer oral », « ③ Érythropoïétine » ; P3 › tableau « hémoglobine et ARISCAT » ; LOT_240 P3 › DX.7 › fenêtre « anémie »

Contexte : Le cours cite l'ESC [S8] (Hb, ferritine, saturation de la transferrine) ; seuils de ferritine/TSAT, délai du fer IV (3 à 8 semaines), adaptation rénale et hépatique du fer oral, spécialité/dose/durée de l'érythropoïétine et valeurs normales suisses de l'Hb non trouvés.

Question : Quels seuils de ferritine et de saturation de la transferrine définissent la carence martiale préopératoire selon le consensus international PBM 2017/2023 et l'ESAIC 2023 ? Quel délai minimal entre fer IV et chirurgie ? Quelles doses de fer IV (Ferinject®, Monofer®) et d'érythropoïétine (spécialités suisses) donne la FI suisse ? Quelles valeurs limites de l'hémoglobine (OMS, femme/homme) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-039 — Haute — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.9 › point 11.B › halopéridol dans le délire (durée), tableaux ECG/QTc et kaliémie, fenêtre « ② Benzodiazépines », tableau « Spécialités suisses » ; point 3 (causes)

Contexte : Le cours cite l'ESAIC 2024 [S13] et la FI Haldol® [S60] : arrêt si QTc > 500 ms, hypokaliémie à corriger ; durée exacte pour le délire, spécialités suisses des benzodiazépines et des autres antipsychotiques, valeurs de référence QTc/kaliémie et causes sous-jacentes non trouvées.

Question : Quelles doses et quelle durée d'halopéridol (et alternatives : quétiapine, rispéridone) dans le délire postopératoire donnent la FI suisse et la recommandation ESAIC la plus récente ? Quelles spécialités suisses de benzodiazépines pour le sevrage alcoolique (lorazépam, oxazépam), avec doses ? Quelles valeurs limites du QTc (homme/femme) ? Donner les doses, voies, adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch), avec la date de la FI.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-029 — Moyenne — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc DX.10 › tableau « Tryptase sérique : interprétation et calendrier » ; fenêtre « Alternative : l'enfant »

Contexte : Le cours applique la règle 1,2 × basale + 2 µg/L ; valeur de base de référence de la population et formule pédiatrique non trouvées.

Question : Quelle valeur de référence de la tryptase basale (µg/L) et quel seuil d'hypertryptasémie (α-tryptasémie héréditaire, mastocytose) retiennent l'EAACI et le consensus international le plus récent ? Une formule adaptée à l'enfant est-elle validée ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-030 — Moyenne — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › fenêtre « quatre délais chirurgicaux » (immédiat, urgent, …)

Contexte : Le cours écrit : définitions horaires des délais chirurgicaux non trouvées.

Question : Quelles définitions horaires de la chirurgie immédiate, urgente, à délai court et élective donne l'ESC 2022 (chirurgie non cardiaque) ou la classification NCEPOD ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-032 — Moyenne — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › fenêtre « ligne directrice GRADE de l'ESA » ; fenêtre « grossesse, enfant, DFGe, contraste, pacemaker » ; P4 › tableau « Test de grossesse préopératoire systématique »

Contexte : Le cours lit seulement le résumé de la ligne directrice ESA (tests recommandés non trouvés) ; test de grossesse préopératoire, enfant, allergie au contraste et pacemaker non documentés.

Question : Quels examens préopératoires (biologie, ECG, radiographie thoracique, test de grossesse) recommande la ligne directrice ESAIC la plus récente sur l'évaluation préopératoire de l'adulte (2018 et mise à jour éventuelle), avec la force de recommandation ? Faut-il un test de grossesse systématique selon l'ESAIC ou la SSAPM ? Quelle conduite préopératoire spécifique pour la femme enceinte (bilan cardiaque, diabète, corticoïdes) et pour l'enfant ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-035 — Moyenne — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.6 › fenêtre « bronchopneumopathie chronique obstructive », fenêtre « Interprétation : spirométrie post-bronchodilatateur », fenêtre « bronchodilatateurs de longue durée » (tableau des spécialités)

Contexte : Le cours cite GOLD 2023 : seuils de VEMS des grades 1 à 4 non lus ; poursuite périopératoire des LABA/LAMA et spécialités suisses non vérifiées.

Question : Quels seuils de VEMS post-bronchodilatateur (en % de la théorique) définissent GOLD 1 à 4 dans la version GOLD la plus récente (2025/2026) ? Quelles spécialités suisses LABA + LAMA (FI) et quelle conduite périopératoire (poursuite le matin de l'intervention) recommandent la Ligue pulmonaire / Société suisse de pneumologie ou l'ERS ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-036 — Moyenne — LOT 238 · SSP O7.16

Emplacement : LOT_238_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › A › Bloc 1 › point 2 ; P1–P4 › point 2 de DX.1, DX.3, DX.4, DX.5, DX.6, DX.7, DX.8, DX.9, DX.10 (fréquences suisses préopératoires)

Contexte : Le cours écrit : fréquences suisses des patients sous AOD, AVK, DAPT, iSGLT2, avec IRC, diabète, BPCO, anémie, délire postopératoire et allergie périopératoire non trouvées ; données ADS 2010, ARISCAT (Espagne) et ALICE (international).

Question : Existe-t-il des données suisses (registre ADS/A-QUA de la SSAPM, OFS statistique médicale des hôpitaux, Obsan) ou européennes récentes sur la prévalence en consultation préopératoire de : anticoagulants, DAPT, diabète, BPCO, insuffisance rénale chronique, anémie ; et sur l'incidence du délire postopératoire et des réactions d'hypersensibilité périopératoires ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-040 — Haute — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › A › fenêtre « B- Honoraires » ; P1 › DX.1 › fenêtre « annonce à l'AI » ; P2 › DX.3 « honoraires du certificat détaillé », DX.4 et DX.5 point 11.D ; P3 › DX.6 fenêtre [S41] ; P4 › DX.10 point 11.D

Contexte : Le cours cite TARMED et l'ASSM 2020 (certificat simple inclus dans la consultation ; détaillé à charge de l'employeur, forfait SIM 100 CHF) et la position 605-CGIAM ; position TARDOC (dès le 1.1.2026) pour certificats et rapports non trouvée.

Question : Quelles positions TARDOC (en vigueur depuis le 1.1.2026) ou forfaits ambulatoires s'appliquent au certificat d'incapacité de travail simple et détaillé, aux rapports à l'assureur-

maladie, aux indemnités journalières, à l'AI (rapport du médecin traitant) et aux certificats de bonne santé ? Donner le code, le libellé, la valeur en points et la source (OFSP, OAAT, FMH, tarifsuisse).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-042 — Haute — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › A › fenêtre « Code des obligations (CO) et Loi sur le travail (LTr) » ; P2 › DX.3 › fenêtre « art. 324a CO »

Contexte : Le cours écrit : la durée du salaire après la 1re année dépend de la jurisprudence ; échelles bernoise, bâloise et zurichoise non lues.

Question : Quelle durée de maintien du salaire (CO art. 324a) prévoient les échelles bernoise, bâloise et zurichoise selon les années de service ? Quels cantons appliquent chaque échelle (source officielle : SECO, tribunaux cantonaux) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-043 — Haute — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › point 9 › aptitude à la conduite (alcool, EtG capillaire) ; A › exemples

Contexte : Le cours cite le seuil EtG de 7 pg/mg (SGRM 2017) ; le consensus plus récent (5 pg/mg pour l'abstinence) n'a pas été lu.

Question : Quel seuil d'éthylglucuronide capillaire (pg/mg) la SSML/SGRM retient-elle aujourd'hui pour l'abstinence et pour la consommation excessive en médecine du trafic ? Le seuil de 5 pg/mg (SoHT 2016/2019, révision 2022) est-il repris en Suisse ? Citer le texte qui le fixe.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-044 — Haute — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › fenêtre « somnolence diurne excessive » (OAC annexe 1 ch. 9) ; recommandations cardiovasculaires d'aptitude

Contexte : Le cours écrit : recommandations suisses sur la somnolence (Société suisse de recherche sur le sommeil, 2017) et recommandations cardiologiques d'aptitude citées mais non lues.

Question : Que dit la recommandation suisse sur la somnolence et l'aptitude à la conduite (SSRSMSC/SGSSC et SSML) : seuils de l'échelle d'Epworth, IAH, délai et preuve d'observance de la CPAP avant reprise, groupes 1 et 2 ? Quelle recommandation suisse sur les maladies cardiovasculaires et l'aptitude à la conduite (SSC/SSML) : délais après syndrome coronarien, syncope, défibrillateur ? Donner titre, année et URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-041 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › A › cadre déontologique ; P2 et P3 › citations du Code FMH (art. 7, 11, 14, 34, annexe 4) ; P3 › Sources (lacunes) ; LOT_241 A › fenêtre « répond » et P1 › Sources (art. 10)

Contexte : Le cours cite le Code de déontologie FMH indirectement (via ASSM/RMS) : fmh.ch refuse l'accès (HTTP 403) ; art. 10 (information) non lu dans le LOT 241.

Question : Quel est le texte intégral en vigueur (version, date) du Code de déontologie de la FMH pour : art. 7 (traitement à distance / télémédecine), art. 10 (information du patient), art. 11, art. 14, art. 34 (certificats médicaux et rapports) et annexe 4 ? Donner l'URL officielle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

D-045 — Moyenne — LOT 239 · SSP O7.17

Emplacement : LOT_239_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc DX.7 › fenêtre « 6,3 % » (directives diabète SGED/SSML 2025) ; point 11.B (Ryzodeg®, antiépileptiques)

Contexte : Le cours a lu les directives diabète et conduite en allemand seulement ; composition et posologie de Ryzodeg® non trouvées ; aucune posologie d'antiépileptique lue.

Question : Existe-t-il une version française officielle des directives SGED/SSML 2025 « Diabète et aptitude à la conduite » ? Quelles catégories de risque hypoglycémique, quels délais après hypoglycémie sévère et quelles obligations d'autocontrôle fixent-elles ? Quelle composition (insuline dégludec + asparte) donne la FI suisse de Ryzodeg® ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P17 — 20 questions : D-025, D-026, D-027, D-031, D-033, D-034, D-037, D-038, D-039, D-029, D-030, D-032, D-035, D-036, D-040, D-042, D-043, D-044, D-041, D-045